

Examen físico del recién nacido

1. Introducción y relevancia clínica

El examen físico del recién nacido (RN) es un procedimiento esencial que permite evaluar la adaptación a la vida extrauterina, detectar malformaciones congénitas, identificar factores de riesgo y establecer la línea base del desarrollo y crecimiento.

Debe realizarse inmediatamente después del nacimiento (evaluación rápida) y luego una evaluación completa dentro de las primeras 24 horas de vida en un ambiente cálido, tranquilo y bajo buena iluminación.

En Chile, el examen forma parte del Control de RN normal según la Guía Perinatal MINSAL 2023, y se realiza en la maternidad y luego en el primer control del Programa de Salud Infantil (niño sano).

En el EUNACOM, este tema se pregunta con frecuencia en casos clínicos sobre hallazgos normales, detección de malformaciones congénitas, signos de displasia de cadera, soplos o anomalías neurológicas.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El examen del RN se fundamenta en tres objetivos fisiopatológicos:

1. Evaluar la adaptación vital inmediata (respiración, circulación, temperatura).
2. Detectar signos de enfermedad congénita o adquirida precoz.
3. Valorar la madurez y el crecimiento según edad gestacional.

Los hallazgos clínicos normales pueden variar según la edad gestacional (prematureo vs. término), por lo que la interpretación debe hacerse considerando la escala de Ballard modificada, que estima la edad gestacional clínica mediante signos neuromusculares y físicos.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El examen debe seguir una secuencia sistemática de pies a cabeza, con observación general, medición antropométrica y evaluación por sistemas.

a. Observación general

- **Actitud y tono:** el RN debe tener movimientos espontáneos, tono flexor y llanto vigoroso.
- **Coloración:**
 - **Rosado:** normal.
 - **Cianosis periférica (acrocyanosis):** frecuente y fisiológica en primeras horas.
 - **Cianosis central:** signo de hipoxia o cardiopatía.
 - **Palidez:** anemia o shock.
 - **Ictericia precoz (<24 h):** siempre patológica.
- **Respiración:** 30–60 rpm, irregular, sin tiraje.

b. Antropometría

Parámetro	Normal RN de término	Significado clínico
Peso	2.500–4.000 g	<2.500: bajo peso; >4.000: macrosomía
Talla	48–52 cm	P90: alerta crecimiento
Perímetro cefálico (PC)	33–36 cm	<32: microcefalia; >37: macrocefalia
Perímetro torácico	30–34 cm	<PC normalmente

Relación peso/talla:

Permite diferenciar prematuro, PEG o RCIU (según curvas OMS o INTERGROWTH).

c. Cabeza y cuello

- **Fontanelas:**
 - Anterior: 2–3 cm, se cierra entre 12–18 meses.
 - Posterior: 0,5–1 cm, se cierra a los 2–3 meses.
 - **Suturas: palpables, móviles.**
 - Fusión precoz → sospechar craneosinostosis.
 - **Moldeado y caput succedaneum:**
 - Edema subcutáneo del cuero cabelludo → fisiológico.
 - **Cefalohematoma:**
 - Hematoma subperióstico limitado a hueso → requiere control.
 - **Ojos: reflejo rojo presente (descartar catarata congénita).**
 - **Boca: paladar íntegro, reflejo de succión.**
 - **Cuello: movilidad libre, ausencia de masas (descartar higroma quístico).**
-

d. Tórax y sistema respiratorio

- **FR: 30–60/min, irregular.**
 - **Tórax simétrico, sin retracciones.**
 - **Ruidos respiratorios: vesiculares, sin crepitantes.**
 - **Mamas: pueden presentar galactorrea neonatal (“leche de bruja”), fisiológica.**
-

e. Corazón y sistema circulatorio

- FC: 100–160/min.
 - Soplos: frecuentes los transitorios en primeras 48 h (ductus o foramen oval), pero si persisten → derivar a cardiología.
 - Pulsos femorales presentes y simétricos: ausentes en coartación de aorta.
 - Perfusión capilar <3 seg.
-

f. Abdomen

- Forma: redondeado, blando.
 - Hígado palpable 1–2 cm bajo reborde costal derecho.
 - Bazo: no palpable.
 - Cordón umbilical: 3 vasos (2 arterias, 1 vena).
 - Sangrado, secreción o eritema → onfalitis.
 - Hernia umbilical: frecuente y benigna en RN sanos.
-

g. Genitales y región anal

Sexo	Hallazgos normales
Masculino	Testículos descendidos, escroto pigmentado. Hidrocele fisiológico posible. Hipospadias = derivación.
Femenino	Genitales hipertrofiados y pigmentados, leucorrea fisiológica o pseudomenstruación por estrógenos maternos.

- Ano permeable: confirmar paso de meconio en primeras 24 h.
 - Ausencia → sospechar atresia anal o enfermedad de Hirschsprung.

h. Extremidades y columna

- **Movimientos simétricos, reflejos presentes.**
 - **Dedos completos, sin polidactilia o sindactilia.**
 - **Displasia de cadera:**
 - **Maniobras de Ortolani y Barlow.**
 - **Asimetría de pliegues o acortamiento → sospecha.**
 - **Columna: sin defectos cutáneos.**
 - **Fóvea sacra profunda o mechón piloso → descartar disrafismo espinal.**
-

i. Sistema neurológico

Reflejos primitivos (presentes en todo RN sano):

Reflejo	Estímulo	Respuesta normal	Desaparición
Moro (sobresalto)	Soltar cabeza brevemente	Extensión y aducción de brazos	4–6 meses
Prensión palmar	Presionar palma	Cierra mano	3–4 meses
Búsqueda	Estimular mejilla	Gira cabeza hacia estímulo	3–4 meses
Succión	Tocar labios	Succión rítmica	4 meses

**Marcha
automática**

Sostener en pie

Patea alternadamente

2 meses

Anormalidades:

- Ausencia unilateral → lesión neurológica o fractura clavicular.
- Persistencia más allá del tiempo esperado → daño neurológico central.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Laboratorios básicos del RN

- Hematocrito: 45–65 %.
- Glicemia: >45 mg/dL.
- Bilirrubina total: <12 mg/dL a las 48 h (sin riesgo).
- Tamizaje metabólico (hipotiroidismo, PKU, fibrosis quística, etc.) dentro de 24–48 h.

b. Evaluación de edad gestacional (Ballard)

Evalúa 6 criterios físicos (piel, lanugo, genitales, mamas, pliegues plantares, pabellón auricular) y 6 neuromusculares (postura, ventana cuadrada, tracción, talón-oreja, etc.).

Permite clasificar RN como prematuro, término o postérmino.

5. Tratamiento y manejo

No requiere tratamiento específico salvo anomalías detectadas.

El manejo del RN sano incluye:

1. Control térmico: ambiente cálido y piel a piel.

2. Apgar y examen físico completo antes de 24 h.
 3. Profilaxis ocular: eritromicina o tetraciclina.
 4. Profilaxis de hemorragia: vitamina K (1 mg IM).
 5. Inicio precoz de lactancia materna.
 6. Tamizajes metabólicos, auditivo y cardiológico.
-

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones por examen incompleto

- No detectar cardiopatías, atresias o displasias → retraso diagnóstico.
- Falta de pesquisa temprana de sepsis o ictericia.

b. Pronóstico

Excelente en RN sanos con examen normal.

El examen completo y sistemático es una herramienta de pesquisa precoz, que reduce morbilidad a largo plazo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. El examen físico completo se realiza dentro de las primeras 24 h.
2. Apgar evalúa adaptación, no reemplaza el examen físico.
3. Fontanela anterior normal: 2–3 cm, se cierra al año y medio.
4. Cefalohematoma no cruza suturas; caput succedaneum sí.
5. Displasia de cadera: se pesquisa con Ortolani/Barlow.
6. Reflejos primitivos simétricos son señal de integridad neurológica.

7. Polidactilia o sindactilia requieren derivación genética.

□ Errores frecuentes:

- **No medir perímetro cefálico o talla.**
 - **Interpretar erróneamente fontanelas o suturas.**
 - **Pasar por alto signos de hipoxia (palidez, cianosis central).**
 - **No revisar permeabilidad anal o genitales.**
 - **Realizar examen con RN frío o sin luz adecuada.**
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

- 1. El examen físico completo del RN debe realizarse dentro de las primeras 24 horas.**
- 2. Incluye observación general, antropometría y examen por sistemas.**
- 3. Fontanelas, reflejos y pulsos femorales son puntos críticos de evaluación.**
- 4. Displasia de cadera, cardiopatías y atresias deben pesquisarse precozmente.**
- 5. Reflejos primitivos simétricos indican madurez neurológica normal.**
- 6. La antropometría permite clasificar RN como AEG, PEG o GEG.**
- 7. Un examen sistemático y documentado mejora el pronóstico neonatal.**